

Urticaire et angioœdème

Introduction : l'urticaire et l'angioœdème sont des manifestations très fréquentes (rencontrées dans 15-20% des consultations chez l'allergologue). Elles sont associées dans 50%, l'urticaire est seul dans 40% et l'angioœdème seul dans 10% des cas : important de spécifier car le DD ne sera pas le même (on pensera à une allergie aux IECA/↓C1q-INH. Voir ci-dessous)

Urticaire : souvent mal perçu par l'entourage, certains patients perdent leur travail en raison d'absentéisme ou parce que les gens autour craignent que ce soit contagieux. Notons que l'urticaire n'est pas spécifique aux allergies, peut aussi se manifester chez enfant après infection virale (crise unique).

Clinique :

- Prurit marqué avec démangeaisons
- Œdème discret sous-jacent à l'érythème
- Lésion fonctionnelle (ne laisse pas de cicatrice)
 - Hypersensibilité de type I
 - Vasodilatation, perméabilité vasculaire accrue
- Evolution dans le temps de la lésion
 - Transitoire (quelques heures)
 - Récurrente ou non
- De plus longue durée (jours) si associée à
 - Réaction inflammatoire de type III (maladie sérique), déficit en C1qINH

Type particulier d'urticaire – **dermographisme** : sensibilité particulière de la peau de certains sujets. Le trouble peut apparaître simplement en écrivant sur la peau avec l'ongle, ou parfois simplement le doigt. Le résultat est un rougissement du tracé effectué, suivi d'un gonflement tout le long de ce tracé dont les contours apparaissent en relief. Il s'agit en fait d'une forme particulière d'urticaire : les "urticaire physiques", c'est-à-dire les urticaire dont le facteur déclenchant la dégranulation des mastocytes est un facteur physique (le froid, l'exposition solaire, la pression cutanée, exposition à l'eau...). Quand on veut faire test cutané pour déceler des allergies, on commence par injecter de l'histamine pour s'assurer que le patient y répond. On doit aussi s'assurer que le patient ne réagit pas à l'eau ou la pression pour exclure un dermographisme (car s'il y a dermographisme il sera impossible de poser le diagnostic!).

Angioœdème : important de faire DD avec maladie infectieuse (ex streptocoque), eczéma aigu (inflammation avec induration, on verra infiltration lymphocytaire dans biopsie) ou syndrome de la veine cave sup (touche aussi creux sous-claviculaires). Parfois l'étiologie peut même être mixte (ex obstruction et allergie).

- Œdème profond (plus que l'urticaire), mal délimité
- Touche surtout les tissus conjonctifs lâches
 - Face: paupières, lèvres, langue
 - Pharynx (œdème de Quincke!)
 - Extrémités
- Déclenche peu de prurit, mais plutôt une sensation de brûlure, de tension, de paresthésies

Étiologie et évolution dans le temps de l'urticaire et angioœdème :

Aiguë (qqh, +/- récurrente) :

- Médinée par les IgE :
 - Aliments : facile si c'est un nouveau aliment, plus difficile s'il y a eu sensibilisation progressive
 - Médicaments (pénicillines, céphalosporines, aspirine...) : très fréquent !
 - Insectes (hyménoptères, fourmis...)
 - Contact (aliments, latex...)

- Non médiée par IgE :
 - Infections (virales banales, HCV, HBV, parasites)
 - Physiques : froid (attention à plongée en mer par exemple, peut aller jusqu'à choc), cholinergique (effort et chaleur...), pression, vibration (ex marteau piqueur)
 - Médicaments
 - histaminolibérateurs (morphiniques...)
 - Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
 - Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC...) : présente quasi toujours angioœdème isolé (urticaire rarement associé).
 - Aliments histaminolibérateurs : fraises, poissons (saumon, thon...toxine scombroïde).
 - Additifs alimentaires : histaminolibérateurs ou vrais allergènes dans très peu de cas
 - Sulfites : dans le vin
 - Parabènes : stabilisent médicaments
- Allergies au glutamate, aspartate, lactate, tartrazine, benzoate et aux additifs E n'ont jamais été prouvées!!! – Mythe, donc ne pas prescrire régime d'éviction inutile/privation abusive!!!

Aiguës à chroniques (>6-8 sem) :

- D'origine autoimmune :
 - Anticorps anti-FcεR1 : déclenche dégranulation des mastocytes
 - Associée à maladies inflammatoires (lupus érythémateux disséminé, maladie sérique), i.e. réaction d'hypersensibilité de type III
 - Probablement liée à des complexes immuns
 - Urticaires ou angioœdème "de longue durée"
 - Associée à autoimmunité thyroïdienne (hypo- ou hyperthyroïdie autoimmune) (? débattu)
- Liée à un défaut du système du complément
 - Déficit en C1q-INH (vasculite urticarienne, voire LES/GN) (complexes C1q/anti-C1q ou consommation de C1q lors de formation de complexes immuns circulants)

Rôle du C1q-INH : inhibe la fibrinolyse, la formation de bradykinine et la voie classique du complément (reconnait les complexes immuns). Un déficit engendre une activation non contrôlée du système du complément. Conséquences :

1. les niveaux de C3 et C4 circulants chutent (car sont utilisés pour activer la phagocytose et créer des complexes comme la C3 convertase)
2. production d'anaphylatoxines C3a et C5a : ↑ perméabilité des VS/expression de molécules d'adhésion.
3. inflammation

Le manque de C1q-INH est d'origine familiale dans 90% des cas (absence de C1q INH = œdème angioneurotique héréditaire). Mais il peut aussi être de forme acquise (mutation sporadique du gène de C1q INH ou lymphome produisant anticorps anti-C1q INH).

Présentation clinique d'un manque de C1q-INH (ou d'un excès de C1q) : angioœdème sans urticaire touchant extrémités, pharynx (Quincke) et tube digestif (crampes, douleurs vives). Les symptômes sont notamment liés à la surproduction de bradykinine. Déclenché par traumatismes (chocs/chir) et infections. Diagnostic met souvent beaucoup de temps à être posé, peut se faire en dosant C1q-INH ou le C4. Attention : C4 plus précis car s'il y a mutation du gène les C1q INH seront présents mais non fonctionnels et seul le C4 sera effondré.

- Urticaire chronique idiopathique (70%)
 - Sans horaire
 - Sans relation avec aucune exposition allergénique quelconque
 - Sans relation avec une atteinte systémique (infections, cancers)
 - Peut durer de 2 mois ...à plusieurs années

Plan d'investigation pour urticaire et angioœdème :

- Anamnèse détaillée/ ex. clinique
- "Carnet de bord"
- Investigations allergologiques spécialisées (prick tests, patch tests, tests in vitro = CAP, tryptase, provocation...)
 - Pas d'indications à des tests systématiques (par ex. IgE alimentaires) si pas d'indication claire
 - Pas d'indication à des régimes d'éviction alimentaire sans documentation

Traitement :

- Étiologique s'il y a lieu – éviction de l'allergène, médicament, etc...
- Antihistaminiques
 - réponse souvent très individuelle : si causé par déficit de C1q-INH, c'est la bradykinine qui est en excès donc les anti-H ne changera rien !!
 - Tester plusieurs anti-H1
 - parfois avantage d'un anti-H1 sédatif
 - essayer association d'anti-H1 (2 à 4 cp/j.)
 - rarement bénéfice à associer un anti-H2 (ranitidine)
- Déficience en C1q-INH
 - Substitution avec forme purifiée de C1q-INH ou TTT d'androgène (chez homme uniquement)
 - Inhibiteur du récepteur de la bradykinine

Pour un rappel sur le complément, revoir le cours de Calandra au 2.2 ☺